内科学含诊断学 风湿系统疾病

有关节骨破坏

核心精讲·类风湿关节炎（内科+外科）

（性感认识：小关节多发对称 CCP）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、RA 概述

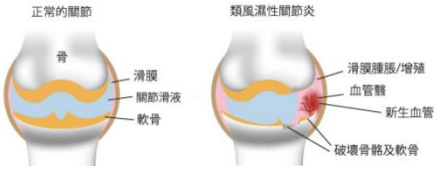
（1）病因：EB 病毒等活化 B 细胞产生 RF 等；CD4 T 细胞；HLA-DRB1、HLA-DR4、TNF-α 基因、球蛋白基因、性别基因

CD8T细胞:不再爱过

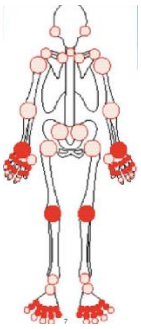
风湿系统疾病大多女性多见(除了强直性脊柱炎)

（2）病理：慢性非特异增生性炎，病变始于关节滑膜形成血管翳,破坏骨头

不是肉芽肿



二、临床表现



（1）**明显晨僵** 晨僵(粘连),无特异性,但大多风湿疾病不会超过30分钟

①每天常≥半小时（《内科学》10 版教材 P815）/≥1 小时（《外科学》10 版教材 P755）

②**休息后加重、活动后减轻**（强直性脊柱炎：休息后加重）特殊

一般疾病:活动后加重

（2）关节痛（最早）、肿胀 类风湿最不容易受累的关节:远端指间关节

①多发（≥3 个关节区）

②**对称** VS 骨关节炎:累及远端指间关节

③好发于**腕关节、掌指关节、近端指间关节**（弹吉他）。类风湿累及手足小关节是其特点，一般早期为手足小关节受累、然后可向心性侵犯四肢大关节 看到大关节(肘关节)受累不能排除类风湿,前提小关节必须受累





（3）晚期关节畸形 关节腔渗出纤维素不容易吸收

①天鹅颈样、纽扣花样、手关节尺侧偏斜 重力原因

②**不可逆、与病情活动性无关、不属于类风湿诊断标准**（三不）

SLE与病情活动性无关:ASSS

（4）关节外表现

容易受压的地方(本质抗体攻击血管壁导致血管通透性↑引起纤维素渗出)

①类风湿结节（皮肤特异表现）：好发于前臂伸面、肘部鹰嘴、跟腱等，皮下结节对称、质硬、无痛

肉芽组织变老瘢痕

免疫复合物刺激

②Felty 综合征：脾大+全血细胞↓（但类风湿活动期血小板可↑）活动期抗体攻击血管

Plt代偿↑修复血管壁

③Caplan 综合征：合并尘肺易出现大量较大肺结节

可能可能最可能：青年女性多见，多发对称性、明显晨僵，主要侵犯小关节（腕/掌指/近端指间关节）

注意：

风湿系统疾病女性多见，但强直性脊柱炎男性多见

类风湿关节炎女性多见，但类风湿结节男性多见

Graves 病女性多见，但周期性瘫痪男性多见

胆囊疾病女性多见，但非结石性胆囊炎男性多见（与动脉粥样硬化有关）

中老年男性多见

雌激素抑制胆囊收缩导致胆汁滞留,更容易发生胆囊疾病

小凯笔记自行整理

	风湿	类风湿
炎症类型	特殊增生性炎	慢性非特异增生性炎
都累及皮肤	环形红斑 皮下结节	类风湿结节
都累及关节	主要渗出浆液 不遗留畸形	主要渗出纤维素 遗留畸形